

24 - Cancer du Col Utérin - Pr. ABOULFALAH

Bonjour tout le monde, ce cours sera consacré à la prise en charge du cancer du colutérin. Le cancer du colutérin représente le deuxième cancer féminin à l'échelle mondiale. Elle est considérée actuellement comme une maladie sexuellement transmissible parce qu'elle est causée dans la majorité des cas par le HPV, Humain Papillomavirus.

Il s'agit aussi d'un cancer dépistable et on va voir tous les moyens pour dépister ce cancer, pour dépister les lésions précancéreuses qui, lorsqu'ils sont bien traités, évitera le cancer. Malheureusement, dans notre pays, ce cancer est souvent découvert à un stade beaucoup plus avancé. Il s'agit d'un cancer qui est radiosensible et radiocurable.

Il existe plusieurs moyens de traitement qui reposent essentiellement sur la chirurgie et puis sur une association concomitante de radiothérapie et de chimiothérapie. Mais le problème qui se pose encore au Maroc, c'est le retard diagnostique. Après cette introduction, on va faire un rappel essentiellement anatomique, puis on va voir l'étude clinique avec le bilan préthérapeutique, les moyens thérapeutiques, que sont leurs indications, les résultats, le pronostic, la surveillance et puis la prévention qui repose actuellement essentiellement sur la vaccination anti-HPV.

Au plan anatomique, le cancer du col naît à partir de la zone de jonctions pavimentaux cylindriques. Alors, comme on voit sur cette coupe frontale du pelvis, le cancer du col, à partir du collet terrain, il peut se propager latéralement vers les paramètres jusqu'à la paroi pelvique. Sur cette coupe sagittale, on voit que le cancer du col, il peut se propager facilement en antérieur vers la vessie, en postérieur vers le rectum, en haut vers l'utérus et en bas vers le vagin.

Le drainage lymphatique dans le cancer du col est très très important parce qu'il s'agit d'un cancer très lymphophile et la propagation se fait de proche en proche vers les ganglions du paramètre et puis vers les ganglions du groupe iliaque externe, iliaque interne. Les iliaques primitifs voient un sein beaucoup plus avancé et se fait vers la chaîne lumbo-aortique. Au plan épidémiologique, il s'agit actuellement du deuxième cancer féminin à l'échelle mondiale, bien évidemment après le cancer du sein.

Il y a des variations géographiques très très importantes. Son prévalence dans les pays en voie de développement reste malheureusement très élevée. Elle est comprise entre 30 et 75 pour 100 000 femmes par an.

Et dans les pays occidentaux, elle est beaucoup plus faible, 17 et 18 pour 100 000 femmes par an, essentiellement par dépistage. Et puis il y a des variations dans le temps. Il y a une diminution de l'incidence dans le temps.

Le cancer du col était le premier cancer de la femme au Maroc dans les années 90 et actuellement, il passe après le cancer du sein. L'âge moyen de ce cancer est entre 40 ans à 60 ans. Et puis les facteurs de risque.

Quels sont les facteurs de risque du retour du cancer du colutérin? C'est dans plus de 80% des cas, il est lié à l'infection par l'HPV. Les facteurs qui déterminent l'infection par l'HPV. On a plusieurs facteurs, essentiellement les partenaires multiples, qu'ils soient de la part de la femme ou du conjoint, les précocités des rapports sexuels, les grossesses multiples et nombreuses, tout terrain immunodéprimé.

Il y a des conditions socio-économiques défavorables. Et aussi la consommation du tabac et des autres drogues peuvent prédisposer à une infection par l'immunopapilloma virus. Sur le plan anatomopathologique, tout d'abord le siège.

Toutes les myoplasies cervicales naissent à partir de la zone de jonction entre les deux hypothéliums pavimenteux et cylindriques. Et ça, c'est quelque chose de capital, parce que pour le dépistage, au niveau de la colposcopie, il faut aller voir cette zone-là et faire le prélèvement à ce niveau-là. Au plan macroscopique, souvent il s'agit d'une forme bourgeonnante exophétique.

Dans la majorité des cas, on peut trouver des formes infiltrantes avec un col enduré ou un col embarillé. Il y a aussi des formes ulcérées qui exposent à la surinfection. Et au plan microscopique, la forme la plus fréquente, c'est le carcinome épidermoïde dans 80 à 90 % des cas.

Cette forme peut être kératinisante ou non. Il faut toujours préciser le grade de la différenciation cellulaire. Est-ce qu'elle est bien différenciée, moyennement différenciée, peu ou carrément indifférenciée.

Et puis on peut trouver un carcinome in situ, puis un carcinome microinvasif, voire invasif. L'adénocarcinome, cette forme, elle est l'apanage surtout de l'endocole. On peut trouver d'autres formes de cancer, en particulier le carcinome à cellules claires.

On peut trouver aussi des sarcomes et des mélanomes. Alors quelles sont les modalités d'extension ? L'extension, elle est tout d'abord locale, à partir de la zone de jonction entre les deux muqueuses de l'exocole et de l'endocole, on va avoir l'extension vers les tissus voisins. Tout d'abord, quand il y a une infection par l'HPV, il y a une transformation cellulaire, cytonucléaire, qui va prendre normalement beaucoup de temps.

Et normalement, de la dysplasie, cancer invasif, ça peut prendre une dizaine d'années. C'est pourquoi, durant ce temps-là d'évolution, il faut faire le dépistage et diagnostiquer ces lésions dysplasiques précancéreuses afin de les traiter et rayer l'évolution vers l'invasion. L'extension loco-régionale, c'est un cancer à évolution essentiellement loco-régionale.

La diffusion est tout d'abord hypothaléale, vers le bas, vers le vagin, et puis vers le haut, vers le col, etc. Il s'agit d'un cancer très lymphophile et la diffusion lymphatique se fait essentiellement vers les ganglions de paramètre pour atteindre les autres groupes ganglionnaires. Et puis cette évolution loco-régionale, si le cancer n'est pas diagnostiqué, n'est pas traité correctement,

l'évolution se fait au-delà de l'utérus, vers la vésicule en avant, le rectum en arrière.

Et puis à un stade beaucoup plus avancé, l'évolution se fait latéralement vers les paramètres, ce qui peut occasionner la compression urétérale qui peut aboutir à l'insuffisance rénale. La diffusion lymphatique est très importante parce qu'il s'agit d'un cancer très lymphophile. Généralement, il se fait de proche en proche, le groupe ganglionnaire le plus concerné, c'est l'iléac externe.

C'est pourquoi dans les traitements, dans les lymphadenectomies, il faut que cette lymphadenectomie intéresse essentiellement le groupe iléac externe. Accessoirement, il se fait vers l'iléac interne, aussi vers les ganglions présacrés, au-delà, à travers le ligament lombo-ovarien. On peut, à un stade beaucoup plus avancé, on peut avoir une atteinte de la chaîne inguinale et puis l'iléac et la chaîne iléac primitive vers la chaîne lombo-aortique.

Et puis, si le cancer n'est pas diagnostiqué et traité à un stade beaucoup plus précoce, on peut observer une extension métastatique qui se fait essentiellement vers le foie, l'os et le poumon, mais cette évolution, elle est rarement, elle se fait rarement au premier plan. Alors là, on va voir le dépistage qui repose essentiellement sur trois éléments, le frottis cervico-vaginal, le test HPV et on verra, pour le diagnostic, beaucoup plus une détection précoce par l'inspection visuelle. Alors, concernant le frottis cervico-vaginal, il doit être fait en deuxième partie du cycle, à distance de rapport et en dehors des saignements.

Classiquement, c'était fait par le frottis conventionnel, on l'appelait le test Papanicolaou, et il est recommandé d'utiliser une spatule d'air associée à une brosse ou un porte-coton ou un cervix brush qui permettent de prélever à la fois au niveau de l'orifice cervical externe et au niveau de l'endocervix. Et c'est quelque chose de très, très important, il faut s'assurer qu'on a bien prélevé la zone de jonction. Le matériel prélevé est étalé sur l'âme de façon uniforme et la fixation doit être immédiate, réalisée à défaut par une laque à cheveux.

Actuellement, le frottis en milieu liquide a remplacé ce frottis conventionnel sur l'âme. Le prélèvement, comme pour le frottis conventionnel, est fait avec un outil adapté, en général avec une brosse, qui va prélever essentiellement la zone de jonction. Le matériel prélevé est mis en suspension dans le flacon qui contient le liquide de conservation.

L'étalement n'est donc pas fait par le clinicien, elle est faite au niveau du laboratoire. Comment interpréter les résultats du frottis ? Il y a 4 classes, soit il y a des cellules normales, une classe de cellules anormales, mais non suspectes, dans la classe 3, il y a une incertitude, et là, il faut refaire le frottis après le traitement éventuellement d'une atrophie vaginale ou d'une infection. Et la classe 4, c'est un frottis suspect qui va nécessiter une prise en charge par la colposcopie.

Quel est le rythme de dépistage par le frottis ? Normalement, dès les premiers rapports sexuels, on doit faire un frottis, et puis un frottis annuel, au moins il faut avoir 2 ou 3 frottis normaux pour alléger la surveillance, et ça dépend des protocoles de chaque pays. Mais en général, il faut faire un frottis annuel jusqu'à 35 ans, pendant 20 ans après les premiers rapports. Au-delà de 35 ans,

60 ans, avec 2 frottis normaux, on fait un frottis annuel chez les femmes à risque, et tous les 3 ans pour les femmes à bas risque.

Un deuxième moyen pour faire le dépistage actuellement, c'est le test à HPV. La technique de la PCR permet l'identification de très faibles taux d'acides nucléiques et virus, la méthode de capture des brides est sensible, et sa quantification exacte, elle convient tout à fait au dépistage, car il est disponible sur forme de kit standardisé. Puis un 3e moyen, c'est l'inspection visuelle, mais là, il s'agit beaucoup plus d'une détection précoce des lésions cancéreuses qu'une véritable méthode de dépistage.

Alors il s'agit de l'inspection visuelle après application au niveau du col d'une solution d'acide acétique, et on fait un examen pendant lequel on applique de l'acide acétique dilué entre 3 à 5% sur le col utérin, et les lésions pré-nucléotiques ou cancéreuses vont avoir un blanchiment. Donc le test est considéré comme négatif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésions acidophiles ou une légère acidophilie, il y a des polypes, mais il n'y a pas de cervicite banale de l'inflammation lorsqu'il y a des cystes de nabote. Le test est considéré comme positif lorsqu'il y a des zones blanches, blanches, opaques, et c'est des lésions qui sont bien définies, denses, avec son marge vers la zone de jonction pavimentaux cylindriques.

Et puis cet examen est suspect de cancer lorsqu'il s'agit de lésions ulcérées, bien visibles, des fois excroissantes, saignant au contact. La détection précoce de cancer peut se faire aussi après l'application de solutions de Lugol et on va regarder directement ce qui se passe au niveau du col. Donc cet examen est dit aussi test de Schiller.

Le test est négatif lorsque l'épithélium pavimenteux devient brun, à cajou, l'épithélium cylindrique ne change pas de couleur ou des zones irrégulières d'absorption partielle de l'iode aux zones d'absorption de l'iode. Le test est considéré comme positif lorsqu'il y a des zones bien définies qui se colorent en jaune, brillant, ne prenant pas l'iode, touchant la jonction pavimentaux cylindriques au proche de l'orifice si la jonction pavimentaux cylindriques n'est pas visible. Et on peut suspecter un cancer en cas de lésions ulcérées ou végétantes visibles cliniquement ou insinuantement ou qui scènent ou touchent.

Alors concernant l'étude clinique, quelles sont les circonstances découvertes? Donc on peut découvrir un cancer lors d'un dépistage par les moyens qu'on vient de voir, mais le maître symptôme c'est lorsqu'il y a des météorologies qui sont provoquées, provoquées par les rapports sexuels ou provoqués par les toilettes intimes. Alors ces météorologies initialement qui sont provoquées vont devenir persistantes, permanentes et spontanées. On peut observer aussi des pertes vaginales, des locaux orais surtout en cas de surinfection de ces lésions.

Et à un stade beaucoup plus avancé on peut avoir l'installation d'une douleur pelvienne. Alors bien évidemment chez toute femme qui saigne, il faut faire un examen cet examen commence par une inspection vulvopérinéale puis un examen sous-spiculaire pour regarder le colutérin faire

un toucher vaginal et un toucher rectal et bien évidemment faire un schéma et dater les lésions. Alors concernant le diagnostic positif, donc l'étude cytologique par le frottis va nous montrer des anomalies cellulaires.

A chaque fois qu'il y a des anomalies cellulaires, il faut avec un frottis suspect, il faut faire une colposcopie un examen oculaire du colutérin direct mais après aussi préparation par l'acide acétique et l'ugole. Donc le frottis va nous donner juste une idée sur la nature des cellules et là c'est la colposcopie qui va nous orienter pour faire la biopsie des zones suspectes à la colposcopie. Alors quand il y a des lésions sur la biopsie des fois on est amené à faire une colonisation du colutérin qui a un but premier c'est un but diagnostique et son deuxième but peut être thérapeutique en fonction de la nature de l'invasion.

Et puis il faut se méfier à chaque fois qu'il y a une lésion macroscopique au niveau du col il ne faut pas faire de frottis ou de colposcopie mais il faut faire une biopsie directe pour l'étude histologique. Une fois le diagnostic fait, on doit faire un bilan préthérapeutique pour classer le cancer du col avant le traitement. Donc il faut faire un bilan d'extension Ce bilan d'extension est tout d'abord loco-régional, il repose essentiellement sur l'examen clinique, le spéculant qui va nous donner sur la localisation, la taille tumorale, le toucher pelvien, le toucher vaginal, le toucher rectal va préciser l'extension vers les organes de voisinage en particulier le vagin mais c'est surtout le toucher rectal qui va préciser l'éventuelle extension vers le paramètre.

Alors le bilan d'extension est essentiellement clinique dans le cancer du col d'état. Puis on peut s'aider par des examens paracliniques qui reposent essentiellement sur l'IRM pelvien, c'est l'examen de choix les supérieurs scanners pour définir l'extension locale en particulier va préciser la taille tumorale, l'atteinte ou non du vagin, des paramètres, l'atteinte de la viscée en avant, l'atteinte du rectum en arrière il va préciser la taille éventuelle extension gonglionaire il va préciser d'autres éléments en particulier la position de l'utérus pour orienter la chirothérapie ses limites, ses lussulations vaginales et bien évidemment il faut des négatifs lorsque il n'y a pas d'adéno-mégalie. A défaut on peut faire un scanner abdominaux pelvien dans les stades supposés avancés surtout dans l'utilisation postérieure il faut faire une rectoscopie pour voir s'il y a une atteinte rectale ou pas, il faut faire une cystoscopie surtout dans les tumeurs antérieures quand il y a une suspicion d'infiltration de la viscée, bien évidemment il faut toujours faire un examen général qui repose sur la clinique toujours évidemment en particulier par l'examen des ergons gonglionaires susclaviculaire et inguinaux il faut rechercher l'hépatomégalie ou un syndrome d'épanchement pleural et sur le paraclinique il faut surtout dans les stades au delà du stade 1 il faut faire une oncographie abdominal à la recherche de métastases au niveau du foie et faire une oncographie rénale afin de rechercher s'il y a une dilatation par compression éréterale au radiothorax dans les stades beaucoup plus avancées quand on suspecte la présence de métastases on peut faire le PET scanner donc il indique surtout dans les formes avancées, ce PET scanner est beaucoup plus performant que le scanner pour l'IRM et on peut regarder les lésions surtout des lésions osseuses dans un stade beaucoup plus avancé donc

après ce bilan préthérapeutique, ce bilan d'extension il faut bien évidemment classer ce cancer avant le traitement, donc il est le stade 0 c'est le carcinome in situ, donc c'est avant l'invasion, puis le stade 1 quand le carcinome est limité le cancer stade 1A c'est des carcinomes micro-invasifs qui sont diagnostiqués sur l'histologie ce stade 1A est divisé en deux stades lorsque l'invasion du stroma est comprise entre 3 mm et inférieure à 3 mm et inférieure à 7 mm d'une manière horizontale lorsque cette invasion du stroma est comprise entre 3 à 5 mm mais toujours l'invasion est inférieure sur le plan horizontal inférieure à 7 mm elle est classée 1 à 2 le stade 1B le stade 1B est divisé en deux et la tumeur là est toujours limitée au col utérin lorsque la taille tumorale est inférieure à 4 cm il s'agit d'un stade 1B1 et au delà de 4 cm elle est classée 1B2 la taille tumorale est très importante sur le plan pronostic et sur le plan de proposition thérapeutique puis on a le stade 2 il s'agit d'un cancer qui va s'étendre au delà de l'utérus mais sans atteinte de paroi pélvienne ni du intérieur inférieur du vagin elle est classée en A et B l'extension dans le stade 2A c'est une extension vaginale sans atteinte de paramètre elle-même est divisée en deux 2A1 lorsqu'elle est inférieure à 4 cm et 2A2 lorsqu'elle est supérieure à 4 cm la taille tumorale est très importante elle est retrouvée dans le stade 1 mais aussi dans le stade 2 le stade 2B lorsqu'il y a un envahissement d'un des deux paramètres ou les deux paramètres donc stade 2B atteinte des paramètres puis il y a le stade 3 il s'agit d'une extension à la paroi pélvienne et ou intérieur inférieur du vagin ou lorsqu'il y a présence d'une hédronéphrose ou un rein muet elle est divisée aussi en stade 3A lorsque l'extension se fait au niveau du intérieur inférieur du vagin sans qu'il y ait une atteinte de la paroi pélvienne et dans le stade 3B il y a une extension jusqu'à la paroi pélvienne avec ou non une hédronéphrose ou un rein muet puis dans le stade 4 elle est divisée aussi en deux il y a une atteinte soit de la vicié soit du rectum, soit qu'il y a déjà des métastases dans le stade 4A c'est toujours le corps régional par atteinte et dans le stade 4B lorsqu'il y a des métastases à distance Alors quels sont les facteurs pronostiques ? Tout d'abord concernant les cancers micro-invasifs la profondeur de l'invasion c'est quelque chose de capital et le risque de récurrence augmente avec la profondeur de l'invasion et le risque de décès aussi augmente avec la profondeur de l'invasion et il faut voir dans ces cancers micro-invasifs s'il y a des embols tumoraux vasculaires ou lymphatiques et la présence d'embols augmente avec la profondeur de l'invasion et il s'agit d'un facteur de mauvais pronostic parce que souvent il y a une atteinte ganglionnaire Alors quels sont les facteurs pronostiques dans les cancers infiltrants, invasifs ? C'est surtout le stade de la figue donc plus on avance dans le stade le taux d'échec est important risque d'apparition de métastases à distance et bien évidemment il va affecter le taux de survie à 5 ans puis il y a le volume tumoral comme je viens de le dire plus le volume est important plus le risque il y a une répercussion sur le taux de survie L'envahissement ganglionnaire a un impact péjoratif sur la survie puis on va retrouver d'autres facteurs mais c'est essentiellement le stade le volume tumoral et l'envahissement ganglionnaire Quels sont maintenant les moyens thérapeutiques donc après le diagnostic positif le bilan préthérapeutique comment on peut traiter ce cancer donc on dispose de plusieurs moyens le premier moyen c'est la chirurgie la radiothérapie, la chimiothérapie et il y en a d'autres moyens adjuvants Quel est le rôle de la chirurgie son rôle c'est l'exercice de la tumeur et de l'extension du corps régional le geste qu'on

peut faire ces interventions locales l'aconisation dans les lésions prégnéoplasiques et il s'agit comme je dis tout à l'heure d'un geste diagnostique qui peut être thérapeutique si on passe en zone saine et qu'il n'y a pas d'invasion l'amputation intravaginale du col on peut proposer aussi la trachelectomie élargie dans les cancers très précoces et lorsqu'on veut préserver la fertilité de la patiente donc il s'agit d'une xérèse élargie du col prenons le paramètre et le 1 tiers supérieur du vagin et puisque c'est un cancer réellement invasif il faut faire une lymphodnectomie pélvienne et bien évidemment on doit conserver l'utérus et les annexes les hystérectomies ces hystérectomies peuvent effectuer par différentes voies la voie classiquement abdominale vaginale et actuellement la voie laparoscopique ou cellioscopique ces hystérectomies sont classées par PIVER en 5 types le type 1 c'est les hystérectomies extra faciales mais là elles sont réservées pour des lésions pénines puis vous avez le type 2 et le type 3 qui sont des véritables interventions de vertègle puis les types 4 et 5 qui sont considérés comme des exonérations partielles plutôt que des hystérectomies simples donc en pratique on admet que le type 1 n'est pas une hystérectomie élargie donc il ne faut pas traiter un cancer du col par une hystérectomie simple les types 4 et 5 se rapprochent plus des exonérations les principales hystérectomies élargies faites pour le col utérin sont des hystérectomies type 2 et type 3 en fonction de l'extension de l'exérèse puis ces interventions peuvent être faites par voie basse et puis les exonérations perviennent c'est à dire qu'on va enlever on va faire une hystérectomie élargie et quand il y a une atteinte la vessie on fait une cystectomie associée donc il s'agit d'une exonération pervienne antérieure et quand il y a une atteinte rectale on fait une exonération postérieure où des fois on est amené à faire une pelvectomie c'est à dire une cystectomie hystérectomie élargie avec exérèse directo-segmuide ces exonérations perviennes sont actuellement proposées en cas de récurrence alors l'anexectomie n'est pas systématique et on peut proposer une conservation anxielle quand la femme est encore jeune désireuse du procès et la tumeur on a parlé de très bon pronostic il doit être au moins inférieur à 2 cm sans qu'il y ait des embôles vasculaires ou lymphatiques l'anexectomie c'est à dire le curage l'onglionnaire peut être fait par l'aparotomie par celluloscopie par voie rétro-peritoneale au niveau pelvin il doit prélever 8 plus ou moins d'onglions de chaque côté et intéresse essentiellement les collecteurs situés entre la veine iléunique saine, le nerf obturateur, l'artère ombilicale et la bifurcation artérielle.

Elle doit enlever les noeuds lymphatiques intéréliques. Et au niveau de l'embout aortique, surtout quand il y a une atteinte pelvienne, elle va concerner, en moyenne, le prélèvement de 11.4, et intéresse les groupes pré-élatéro-cave, pré-élatéro-aortique et inter-aortico-cave. Donc, comme je viens de le dire, la conservation ovarienne est proposée chez la femme jeune, moins de 40 ans, avec une tumeur inférieure à 2 cm.

Il faut que ce carcinome soit bien différencié, et l'absence d'embout vasculaire ou lymphatique. Il faut, bien évidemment, après cette chirurgie, analyser la pièce opératoire pour déterminer de façon définitive la taille du moral, les berges de réjection, s'ils sont sains ou pas, le statut gonglionnaire, le nombre de gonglions prélevés, sa localisation, est-ce qu'il y a un rupture capsulaire ou pas. Il faut voir s'il y a la présence ou non d'embout lymphatique ou vasculaire.

Bien évidemment, le type histologique, et voir s'il y a ou pas une atteinte des paramètres. Cette chirurgie, elle est lourde, elle expose à une morbidité, une mortalité qui peut être très importante. La mortalité varie de 0 à 31 % et souvent on trouve une maladie thromboembolique, donc c'est pourquoi la prévention par les anticoagulants est très, très importante.

La patiente aussi peut décéder par une hémorragie, parce que quand on fait l'opérage, l'lymphodnectomie, on risque de toucher les gros vaisseaux. Des fois, la patiente peut se surinfecter. Et puis, il y a beaucoup de complications urinaires, en particulier au niveau des oesophères et de la viscille, avec des fistules ou des sténoses à long terme au niveau des oesophères.

Et puis, quand on fait l'opérage, il y a toujours le risque d'un fessel qui atteint 5 à 10 % des patientes. Quelles sont les indications? Alors, on va voir les indications. Donc, pour le stade 1A, les indications vont dépendre essentiellement du stade.

Le stade 1A, sans embole vasculaire. Donc, on peut proposer juste une colonisation et un sano pour conserver la fertilité. Sinon, chez une patiente qui a déjà des enfants et qui désire plus de procès, on peut proposer une hystérectomie simple.

Pour le stade 1A, avec des embolies vasculaires, il faut proposer une hystérectomie radicale, modifiée avec une lymphodnectomie pervienne du fait qu'il y a des embolies vasculaires. Sinon, on peut proposer aussi une trachelectomie radicale avec l'lymphodnectomie laparoscopique pour conserver la fertilité de la patiente. Alors, pour le stade 1A, le stade 1A2, on peut proposer une hystérectomie simple, une colpo-hystérectomie élargie type PIVER 2, une colonisation et un sano, une curiothérapie en cas de contradiction à la chirurgie.

Si l'lymphodnectomie non réalisée, il faut faire une surveillance. Et s'il est réalisé et les conclusions sont positives, il faut faire une radiochimiothérapie concomitante. Alors, concernant le stade 1B1, le stade 2A1, on peut proposer une chirurgie type hystérectomie élargie avec l'lymphodnectomie pervienne, une irradiation exclusive, radiothérapie simple, plus curiothérapie, une association radiochirurgicale, curiothérapie, hystérectomie avec l'lymphodnectomie.

Concernant le stade 1B1 et le stade 2A1, le choix de la stratégie thérapeutique doit tenir compte de plusieurs paramètres. L'âge et la stature menale de la patiente, le désir de grossesse, est-ce qu'il y a une comorbidité, la taille tumorale et le type histologique. Dans le stade précoce 1A1, 1B1 et 2A1, quels sont les facteurs de mauvais pronostic après la chirurgie ? La présence ou non de métastases gonglionnaires, les marges positives, l'atteinte des paramètres.

Donc il s'agit d'un facteur de hauts pronostics. Il faut voir la profondeur de l'invasion du stroma, la présence d'un bol vasculaire ou lymphatique, la taille tumorale supérieure à 4 cm. Ce sont des facteurs de risques élevés, de risques intermédiaires.

Dans le stade avancé, c'est souvent une association concomitante de radiothérapie. Et en

fonction de la réponse, on peut proposer une chirurgie de clôture qui est controversée actuellement. Maintenant, quelle est la prise en charge des néoplasies cervicales intra-hépato-utérines ? Ce sont les indications thérapeutiques des lésions de bas grade.

Lorsqu'il y a une discordance entre un des éléments diagnostiques, c'est-à-dire le frottis ou la colposcopie, et si le frottis ou la colposcopie sont en faveur d'une lésion beaucoup plus sévère, on peut proposer une conisation afin d'avoir une certitude de diagnostic histologique. Si la zone de jonction pavimentocylindrique est non vue ou seulement vue d'une manière partielle, il faut aussi proposer une conisation afin d'avoir une certitude de diagnostic histologique. Et puis, lorsque tous les éléments concordent et la zone de jonction est totalement visible, la décision thérapeutique, c'est d'apprendre avec la patiente, qui doit être informée des avantages et des inconvénients des différentes options thérapeutiques, et ce choix se fera entre un traitement immédiat par une destruction utilisant préférentiellement la vaporisation laser et une surveillance qui consiste à faire un frottis ou une colposcopie à six mois, éventuellement avec une biopsie.

Et là, trois situations sont alors possibles. Des examens normaux avec disparition de lésions, et là, on va faire un contrôle cytotopocorpique à un an. S'il y a une aggravation d'un de plusieurs éléments du trépied, il faut proposer une X-rays.

En cas de persistance des anomalies sans aggravation des éléments du trépied, on peut proposer une surveillance avec contrôle cytotopocorpique tous les six mois pendant un an supplémentaire avec les mêmes options, et puis la surveillance post-opératoire est indispensable dans tous les cas. Quelles sont les indications thérapeutiques des lésions de haut grade ? L'examen colposcopique est indispensable pour le choix de la méthode et qui doit préciser le siège, la taille des lésions et l'importance de la zone de transformation. Le choix de la méthode thérapeutique doit prendre en compte le désir de la grossesse de la patiente et sa compléxité pour le traitement.

Et les méthodes de résection habituellement indiquées chez la neuropathe en fonction de la hauteur de la résection céduale doivent être la plus réduite possible, mais il faut exiger des limites saines. Les méthodes de destruction ou vaporisation au laser ou cryothérapie peuvent être proposées chez une femme désirant une grossesse et qui accepte un suivi régulier si les conditions suivantes sont respectées. Les lésions de petite taille, du siège uniquement exocervical est totalement visible à la colposcopie.

Quel est maintenant le pronostic du cancer du col ? Les lésions sauvages peuvent être proposées sansJaack. Ces lésions de petite taille peuvent être proposées chez une femme désirant une grossesse et qui accepte un suivi régulier si le genre pour les lésions du col est nécessaire. Quelles sont la l' What percent would she take if after 3 ans et puis tous les ans à vie après les trois premières années.

Donc on peut avoir au niveau de la surveillance une récurrence et là en fonction de la récurrence on

peut proposer une chirurgie ou un traitement palliatif par radiochimiothérapie en fonction de la dose de radiothérapie utilisée initialement. Là c'est quelque chose de très important dans la prévention il existe des vaccins actuellement comme j'ai dit la cause du cancer c'est l'HPV mais pas uniquement du cancer du colutérin mais aussi du cancer du vagin cancer de l'anus, des cancers oropharyngé qui sont secondaires à l'infection par l'HPV. Donc la vaccination elle est proposée avant la survenue de la première infestation et l'objectif c'est de permettre de synthétiser des anticorps sériques et qui par transsudation vont protéger, vont neutraliser le virus avant qu'il infecte les keratinocytes.

Alors le principe c'est un vaccin susunitaire basé sur la protéine L, la capside virale, il n'y a pas de matériel génétique oncogène, il n'y a pas d'effet infectant, il n'y a pas d'effet oncogène et qu'il confère une immunité très très forte. Actuellement il y a deux types de vaccins, le Gardasil et le Servarix qui sont utilisés pour la prévention du cancer mais aussi en particulier le Gardasil aussi pour la prévention des condylomes aussi bien chez la femme que chez l'homme. Là on voit une représentation schématique de la production de l'HPV lors de la vaccination au moyen de pseudoparticules virales.

La réponse immunitaire est beaucoup plus importante à l'âge pré-pubertaire, il y a un risque de contamination beaucoup plus faible avec l'âge donc il faut vacciner à partir de 14 ans et essentiellement avant le premier rapport mais on peut toujours proposer une vaccination de rattrapage c'est à dire à n'importe quel âge. La durée de protection, il y a persistance d'immunité induite par la vaccination au long ou au moins 10 ans actuellement et le Servarix c'est vrai qu'il diminue dès la première année mais reste significativement élevé même après cinq ans. En conclusion le pronostic du cancer du col dépend essentiellement du stade dans les formes localisées et les curables de très bon pronostic dans les formes avancées le pronostic est très altéré et afin d'améliorer le pronostic il faut faire un diagnostic précoce, la prise en charge doit être multidisciplinaire et le mieux traitement c'est en fait le dépistage de lésions pré-néoplasiques par les différents moyens de dépistage.

Actuellement il y a un moyen de prévention primaire qui repose sur la vaccination anti HPV et je vous remercie